

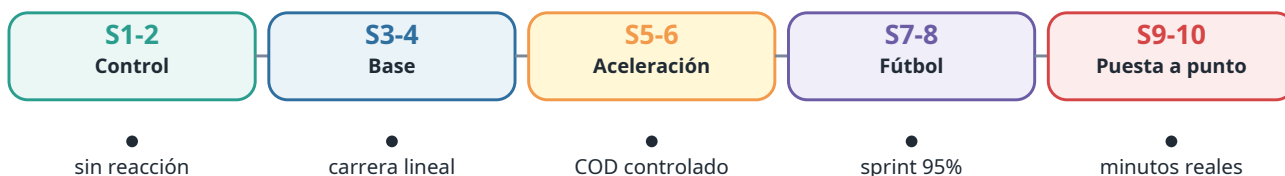
Informe de readaptación futbolística

Dolor inguino-púbico / athletic pubalgia sin hernia verdadera

Objetivo deportivo

Llegar a septiembre con capacidad real de correr, frenar, girar, chutar y competir sin reacción al día siguiente. El plan no es reposo: es una pretemporada médica y progresiva.

Línea de tiempo hasta septiembre



COD = cambio de dirección. El calendario solo avanza si los criterios de dolor y función se cumplen.

Fecha de inicio: 23 de junio de 2026. Horizonte: primeras semanas de septiembre. Documento orientativo para imprimir, llevar en el móvil y enseñar a médico/fisioterapeuta/readaptador.

Aviso importante

Este documento no confirma un diagnóstico ni sustituye una exploración. Está construido bajo la hipótesis operativa de dolor inguinal relacionado / pubalgia atlética sin hernia. Si aparece bulto inguinal, dolor progresivo con tos o Valsalva, dolor testicular fuerte, fiebre, dolor nocturno o incapacidad para caminar, hay que consultar de forma prioritaria.

1. Resumen ejecutivo

La hipótesis de trabajo es que el problema pertenece al espectro de dolor inguino-púbico del deportista: zona baja abdominal, canal inguinal, pubis, aductores y complejo recto abdominal-aductor. En este modelo, el dolor puede sentirse como abdominal, como ingle o como aductor porque esas estructuras trabajan juntas cuando aceleras, frenas, giras o golpeas el balón.

La prioridad no es poner una etiqueta perfecta, sino organizar una vuelta al campo basada en criterios: dolor bajo, fuerza de aductores, control de pelvis, carrera lineal, aceleración, frenada, cambio de dirección, balón y competición. El calendario solo sirve si el cuerpo permite avanzar.

Lectura para niño de 10 años

Imagina que tu ingle es una tienda de campaña. Los aductores son una cuerda, los abdominales otra cuerda y el pubis es la piqueta del centro. Si una cuerda tira mal, la tienda se mueve. Tu trabajo estas semanas es tensar las cuerdas poco a poco, no pegar un tirón fuerte el primer día.

Idea clave	Traducción práctica
No hay hernia verdadera asumida	Aun así, si aparece bulto o dolor fuerte con tos, se revisa. La hipótesis no es una garantía.
No se vuelve por calendario	Se vuelve por pruebas: sin dolor, fuerza, sprint, giro, golpeo y recuperación al día siguiente.
La zona no quiere heroicidades	Muchos problemas de pubalgia recaen por correr o chutar fuerte demasiado pronto.
Septiembre se gana en julio-agosto	Si en agosto no toleras velocidad y cambios de dirección, septiembre competitivo queda comprometido.

2. Qué problema estamos entrenando

El dolor inguinal del deportista se suele clasificar por zonas clínicas: aductor, iliopsoas, canal inguinal, pubis, cadera u otras causas. En tu caso, el patrón se interpreta como combinación probable de componente inguinal y aductor, con posible participación del complejo recto abdominal-aductor. Esa es la hipótesis de trabajo, no una sentencia médica.

Por qué molesta al correr, girar o driblar

Cuando aceleras, una pierna empuja el suelo y la otra avanza. Los aductores ayudan a cerrar y controlar la pierna. Los abdominales estabilizan el tronco. El pubis recibe fuerzas de ambos lados. En sprint, frenada, cambio de dirección y chut, esa zona recibe tirones rápidos. Si está irritada, el cuerpo protege: corres menos, giras peor y notas sobrecarga en aductores.

Por qué puede doler con tos o estornudo

Toser o estornudar sube la presión dentro del abdomen. Si la pared baja abdominal o el canal inguinal están sensibles, esa presión reproduce dolor. No significa automáticamente hernia, pero obliga a vigilar. Si aparece un bulto, sensación de masa o dolor que empeora con Valsalva, hay que descartar hernia de nuevo.

Semáforo de dolor: regla simple

0-2 Verde	3 Amarillo	4 Naranja	5+ Rojo
entreno permitido	mantén, no subas	baja carga	para y revisa

Si el dolor aumenta al día siguiente, la sesión fue demasiado agresiva aunque durante el entrenamiento pareciera tolerable.

Señales de alarma

Consulta de forma prioritaria si aparece bulto inguinal que aumenta al toser, dolor intenso y progresivo, náuseas/vómitos, incapacidad para expulsar gases, dolor testicular agudo, fiebre, dolor nocturno fuerte, pérdida de fuerza clara o incapacidad para apoyar la pierna.

3. Principios del plan

Regla	Qué significa
Dolor 0-2/10	Puedes entrenar. La zona trabaja, pero no protesta de forma clara.
Dolor 3/10	No subas carga. Repite la misma dificultad o reduce un poco.
Dolor 4/10 o más	Para esa parte. Vuelve a una variante más fácil.
Reacción al día siguiente	La sesión fue demasiado dura aunque durante el entrenamiento pareciera bien.
Progresión	Primero control, luego fuerza, luego carrera, luego giro, luego balón, luego partido.
No mezclar todo pronto	Correr rápido + girar + chutar + fatiga es la mezcla más agresiva.

Norma simple: no intentes demostrar que estás curado. Haz pruebas pequeñas cada semana para demostrar que puedes tolerar más carga sin pagar al día siguiente.

Criterios mínimos antes de fútbol intenso

Tos o estornudo sin dolor claro o con molestia mínima.

Aducción isométrica fuerte sin dolor superior a 2/10.

Copenhagen corto y después largo sin reacción.

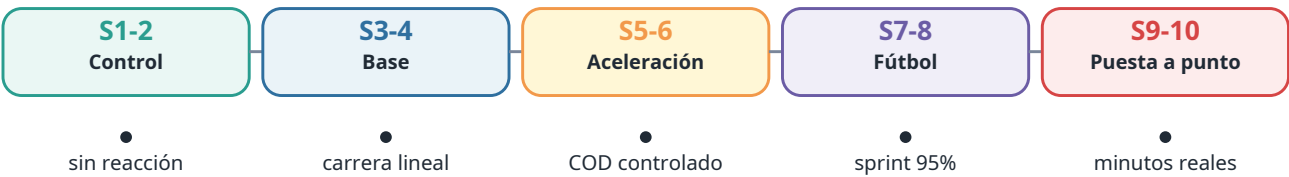
Carrera lineal 30 minutos o progresivos al 80-85% sin reacción.

Frenar, girar 90 grados y volver a acelerar sin protegerte.

Chutar de forma progresiva sin dolor durante ni al día siguiente.

4. Plan general de 10 semanas

Línea de tiempo hasta septiembre



COD = cambio de dirección. El calendario solo avanza si los criterios de dolor y función se cumplen.

Bloque	Qué haces	Señal de avance
Semanas 1-2	Control del dolor, movilidad, isométricos de aductor, core básico, fuerza ligera, cardio sin impacto agresivo, balón suave.	Menos dolor con tos, adducción isométrica tolerada, carrera suave sin reacción.
Semanas 3-4	Copenhagen corto, fuerza de pierna moderada, carrera lineal, progresivos al 60-75%, técnica de balón sin duelo.	Copenhagen corto 3 x 10, carrera lineal 70-75%, cero reacción al día siguiente.
Semanas 5-6	Copenhagen largo progresivo, fuerza más seria, aceleraciones 10-20 m, frenadas suaves, cambios 45-90 grados.	Sprint 85-90%, cambios de dirección controlados, golpeo 60-70%.
Semanas 7-8	Velocidad 90-95%, COD 90-135 grados, fútbol específico, posesiones suaves, chut 70-90%.	Tres sesiones de campo en una semana sin reacción.
Semanas 9-10	Puesta a punto: sprint de calidad, fútbol con oposición, minutos controlados, fuerza de mantenimiento.	Minutos reales sin reacción 24-48 h.

Regla de septiembre

Solo juegas partido completo si ya has tolerado varias sesiones con velocidad, frenada, giro, balón y oposición. Si no, entras por minutos: 20-30, luego 45, luego 60-75 y solo después partido completo.

Fase 1. Semanas 1-2: apagar irritación y recuperar control

Objetivo	Que la zona deje de estar reactiva. No es descanso total: es carga baja y bien elegida.
Trabajo diario	Movilidad de cadera 10 min, respiración y brace 5 min, core básico 10 min.
Fuerza	3 días/semana: isométricos de aductor, puente de glúteo, side plank, split squat corto, RDL ligero, gemelo.
Campo	Bici, elíptica o carrera muy suave. Balón solo técnico: pases, controles, conducción lineal.
Prohibido	Sprint, cambios de dirección fuertes, chut potente, abdominales pesados, partido.

Fase 2. Semanas 3-4: base de fuerza y carrera lineal

Objetivo	Construir motor sin meter caos. La pierna aprende a empujar otra vez.
Fuerza	3-4 días/semana: Copenhagen corto, aductor con banda, split squat, RDL, hip thrust, Pallof press.
Carrera	Progresivos lineales: 10 x 60 m al 60-65%; luego 6 x 80 m al 65-75%.
Balón	Conducción lineal, pases medios, controles orientados. Chut solo 40-50%.
Avance	Copenhagen corto sin dolor y carrera al 70-75% sin reacción.

Fase 3. Semanas 5-6: fuerza seria, aceleración y cambios controlados

Objetivo	Pasar de correr suave a parecer futbolista: acelerar y frenar sin protegerte.
Fuerza	Copenhagen largo progresivo, aductor excéntrico, sentadilla/trap-bar, split squat, lateral lunge, Nordic asistido.
Campo	6-8 x 10 m al 70-80%, 4-6 x 20 m al 75-85%, frenadas suaves, cambios de dirección 45 y 90 grados.
Balón	Dribbling amplio, golpeo 50-70%, pases largos progresivos.
Avance	Sprint al 85-90%, cambios 90 grados y golpeo moderado sin reacción.

Fase 4. Semanas 7-8: velocidad, agilidad y fútbol específico

Objetivo	Volver a gestos reales: arrancar, frenar, girar, recibir, driblar y chutar.
Fuerza	2-3 días/semana. Menos volumen, buena intensidad: Copenhagen, fuerza pierna, pliometría lateral, core.
Velocidad	Aceleraciones 10-30 m al 85-95%, progresivos 40-60 m, cambios 90-135 grados y 180 controlado.
Fútbol	Rondos, posesiones pequeñas, conducción rápida, reacción, finalización 70-90%.
Avance	Tres sesiones de campo en una semana sin reacción.

Fase 5. Semanas 9-10: puesta a punto competitiva

Objetivo	Pasar de readaptación a rendimiento. Mantener fuerza y meter minutos reales.
Semana tipo	Fuerza mantenimiento, velocidad, fútbol técnico-táctico, recuperación activa, partido/minutos controlados.
Minutos	Primero 20-30 min, luego 45, luego 60-75. Partido completo solo si no hay reacción.
Mantenimiento	Copenhagen 1-2 veces/semana, core 2 veces/semana, fuerza pierna 2 veces/semana, sprint de calidad 1-2 veces/semana.
Avance	Juegas sin dolor y al día siguiente no hay aumento de síntomas.

5. Semanas tipo

Estas semanas tipo son plantillas. Si una sesión deja reacción al día siguiente, no repitas la semana más fuerte: repite o baja un escalón.

Fases 1-2

Día	Trabajo
Lunes	Fuerza aductor-core + cardio suave
Martes	Técnica de balón suave + movilidad
Miércoles	Fuerza pierna + isométricos
Jueves	Zona 2: bici/elíptica/carrera suave + core
Viernes	Fuerza aductor-core + progresivos lineales
Sábado	Balón controlado + acondicionamiento bajo
Domingo	Descanso real + test semanal

Fases 3-5

Día	Trabajo
Lunes	Fuerza pesada + aceleración corta
Martes	Balón técnico + carrera tempo
Miércoles	Fuerza aductor-core + movilidad
Jueves	Sprint/COD progresivo
Viernes	Fuerza ligera + balón
Sábado	Fútbol específico / posesiones / minutos controlados
Domingo	Descanso real + test semanal

6. Biblioteca de ejercicios: explicado fácil

En cada ficha piensa así: primero haces la versión fácil, luego más difícil. Si duele demasiado, no eres débil: elegiste una versión demasiado fuerte para ese día.

Regla técnica

Muévete lento, respira, no aprietes la mandíbula y no hagas trampas. Mejor 6 repeticiones limpias que 20 malas.



Respiración + brace abdominal

Para qué sirve: Enseñar al abdomen a ponerse firme sin bloquearse.

Cómo se hace:

1. Túmbate boca arriba con rodillas dobladas.
2. Coge aire por la nariz como si inflaras una barriga pequeña.
3. Suelta aire lento y aprieta el abdomen como si alguien fuese a darte un toque suave.
4. Mantén esa firmeza 5 segundos sin aguantar la respiración.

Bien hecho se siente: abdomen firme pero puedes hablar

Error típico: hacer fuerza máxima o quedarse sin respirar

Sube de nivel cuando: puedes mantener 10 repeticiones sin dolor ni presión rara en la ingle



Aducción isométrica con balón/toalla

Para qué sirve: Activar aductores sin movimiento brusco.

Cómo se hace:

1. Túmbate boca arriba o siéntate.
2. Pon una pelota, cojín o toalla entre las rodillas.
3. Aprieta como si quisieras aplastarla, pero solo al 40-60% al principio.
4. Mantén 30-45 segundos y descansa.

Bien hecho se siente: trabajo en cara interna del muslo, sin pinchazo

Error típico: apretar al 100% el primer día

Sube de nivel cuando: 5 series de 45 segundos con dolor 0-2/10



Dead bug

Para qué sirve: Coordinar abdomen y piernas sin tirar de la ingle.

Cómo se hace:

1. Túmbate boca arriba, brazos arriba y rodillas a 90 grados.
2. Aprieta suave el abdomen.
3. Baja un brazo y la pierna contraria despacio, como un robot lento.
4. Vuelve al centro y cambia de lado.

Bien hecho se siente: abdomen trabajando y espalda pegada al suelo

Error típico: arquear la espalda o mover rápido

Sube de nivel cuando: 3 x 10 por lado sin perder control



Bird dog

Para qué sirve: Controlar pelvis y espalda mientras se mueven brazo y pierna.

Cómo se hace:

1. Ponte a cuatro patas.
2. Estira un brazo y la pierna contraria.
3. Imagina que llevas un vaso de agua en la espalda y no quieres tirarlo.
4. Mantén 2 segundos y cambia.

Bien hecho se siente: glúteo y abdomen suaves

Error típico: girar la cadera o levantar demasiado la pierna

Sube de nivel cuando: 3 x 10 por lado sin moverte como barco



Plancha lateral corta

Para qué sirve: Fortalecer lateral del tronco y pelvis.

Cómo se hace:

1. Apoya antebrazo y rodillas de lado.
2. Levanta la cadera del suelo.
3. Haz una línea recta hombro-cadera-rodilla.
4. Mantén 20-30 segundos.

Bien hecho se siente: trabajo lateral, no dolor en ingle

Error típico: hundir la cadera o encoger el hombro

Sube de nivel cuando: 3 x 30 segundos por lado sin dolor



Pallof press

Para qué sirve: Entrenar al cuerpo a no girarse cuando una fuerza tira de él.

Cómo se hace:

1. Ata una goma a un punto fijo a la altura del pecho.
2. Ponte de lado a la goma y sujétala con dos manos.
3. Estira los brazos al frente sin dejar que el tronco gire.
4. Vuelve lento.

Bien hecho se siente: abdomen firme, pies estables

Error típico: girar el cuerpo o bloquear respiración

Sube de nivel cuando: 3 x 12 por lado con goma moderada



Puente de glúteo

Para qué sirve: Activar glúteos para que la ingle no haga todo el trabajo.

Cómo se hace:

1. Túmbate boca arriba con rodillas dobladas.
2. Aprieta glúteos.
3. Sube la cadera hasta formar una línea hombros-cadera-rodillas.
4. Baja lento.

Bien hecho se siente: glúteos trabajando más que lumbar

Error típico: empujar con la espalda o abrir/cerrar rodillas

Sube de nivel cuando: 3 x 15 sin molestia



Split squat corto

Para qué sirve: Fortalecer pierna en posición parecida a zancada sin exigir mucho giro.

Cómo se hace:

1. Pon un pie delante y otro detrás.
2. Baja poco al principio, como un ascensor lento.
3. La rodilla delantera mira al frente.
4. Sube empujando el suelo.

Bien hecho se siente: muslo y glúteo, control

Error típico: rodilla hacia dentro o bajada demasiado profunda

Sube de nivel cuando: 4 x 8 por lado sin dolor



Peso muerto rumano

Para qué sirve: Fortalecer isquios, glúteo y espalda baja con bisagra de cadera.

Cómo se hace:

1. Ponte de pie con poco peso o una mochila.
2. Lleva la cadera hacia atrás como si cerraras una puerta con el culo.
3. Espalda larga, rodillas un poco dobladas.
4. Sube apretando glúteos.

Bien hecho se siente: parte posterior de pierna, no tirón inguinal

Error típico: doblar la espalda o bajar demasiado

Sube de nivel cuando: 4 x 8 controlado



Copenhagen corto

Para qué sirve: Fortalecer aductor con palanca pequeña.

Cómo se hace:

1. Túmbate de lado junto a un banco/silla estable.
2. Apoya la rodilla de arriba sobre el banco.
3. Levanta la cadera como una plancha lateral.
4. Sube y baja lento.

Bien hecho se siente: aductor fuerte, pero dolor 0-2/10

Error típico: hacerlo con pierna estirada demasiado pronto

Sube de nivel cuando: 3 x 10 por lado sin reacción



Copenhagen largo

Para qué sirve: Versión más difícil para preparar sprint, giro y chut.

Cómo se hace:

1. Igual que el corto, pero apoyas el tobillo/pie de arriba.
2. Mantén cuerpo recto.
3. Sube cadera despacio.
4. Baja sin caer.

Bien hecho se siente: aductor trabajando fuerte, controlado

Error típico: colapsar cadera o hacerlo con dolor

Sube de nivel cuando: 3 x 6-8 por lado sin dolor al día siguiente



Aductor con banda o polea

Para qué sirve: Dar fuerza específica al cierre de la pierna.

Cómo se hace:

1. Ata una goma al tobillo.
2. Ponte de lado al punto fijo.
3. Cruza la pierna hacia dentro despacio.
4. Vuelve controlando, sin látigo.

Bien hecho se siente: trabajo claro en aductor

Error típico: usar goma demasiado dura y compensar con tronco

Sube de nivel cuando: 3 x 12 con control perfecto



Lateral lunge

Para qué sirve: Preparar la pierna para movimientos laterales.

Cómo se hace:

1. Pies separados.
2. Lleva el peso hacia un lado doblando esa rodilla.
3. La otra pierna queda más estirada.
4. Empuja el suelo para volver al centro.

Bien hecho se siente: glúteo/aductor con control

Error típico: caer rápido o dejar rodilla hacia dentro

Sube de nivel cuando: 3 x 6 por lado sin pinchazo



Nordic hamstring asistido

Para qué sirve: Proteger isquios para sprint y frenada.

Cómo se hace:

1. Arrodíllate con tobillos sujetos o con ayuda.
2. Inclínate hacia delante muy poco al principio.
3. Frena la caída con isquios.
4. Usa manos para volver si hace falta.

Bien hecho se siente: tensión en parte posterior del muslo

Error típico: bajar demasiado y romper técnica

Sube de nivel cuando: 3 x 5 controlado



Pliometría lateral baja

Para qué sirve: Enseñar a caer y empujar lateralmente sin sustos.

Cómo se hace:

1. Da saltitos laterales pequeños.
2. Cae suave, como gato.
3. Rodilla mira al frente.
4. Empuja al otro lado sin prisa.

Bien hecho se siente: reactivo pero controlado

Error típico: hacer saltos grandes demasiado pronto

Sube de nivel cuando: 3 x 8 por lado sin dolor



Adductor rockback

Para qué sirve: Mover cadera y aductor sin estirar agresivo.

Cómo se hace:

1. Ponte a cuatro patas.
2. Estira una pierna hacia el lado.
3. Lleva el culo hacia atrás despacio.
4. Vuelve al centro.

Bien hecho se siente: estiramiento suave interno del muslo

Error típico: forzar hasta dolor

Sube de nivel cuando: 2 x 10 por lado cómodo



90/90 de cadera

Para qué sirve: Mejorar rotación de cadera para girar mejor.

Cómo se hace:

1. Siéntate con una pierna delante a 90 grados y otra detrás a 90 grados.
2. Mantén espalda larga.
3. Cambia de lado despacio.
4. No fuerces la ingle.

Bien hecho se siente: cadera se mueve, no pincha

Error típico: caer hacia atrás o forzar rodilla

Sube de nivel cuando: 2 minutos por lado sin dolor



Carrera lineal progresiva

Para qué sirve: Volver a correr sin meter giros.

Cómo se hace:

1. Empieza con carrera suave.
2. Haz rectas de 60-80 m al 60-70%.
3. Camina de vuelta para recuperar.
4. Sube intensidad poco a poco cada semana.

Bien hecho se siente: zancada limpia y sin protección

Error típico: picarte y correr al máximo

Sube de nivel cuando: 6-10 rectas sin reacción 24 h



Aceleraciones 10-20 m

Para qué sirve: Preparar arrancadas de fútbol.

Cómo se hace:

1. Colócate de pie, sin salida explosiva al principio.
2. Acelera 10 m al 70-80%.
3. Frena suave y camina de vuelta.
4. Sube a 20 m si no hay reacción.

Bien hecho se siente: potencia controlada

Error típico: salida máxima demasiado pronto

Sube de nivel cuando: 8 repeticiones al 80-85% sin dolor



Frenadas

Para qué sirve: Aprender a detenerte sin que tire la ingle.

Cómo se hace:

1. Corre 10-15 m moderado.
2. Frena en 3-4 pasos, no en seco al principio.
3. Rodillas flexionadas, tronco estable.
4. Después camina y repite.

Bien hecho se siente: cuádriceps/glúteo trabajando

Error típico: clavar el pie y girar a la vez

Sube de nivel cuando: 6-8 frenadas fuertes sin reacción



Cambio de dirección 45/90/180

Para qué sirve: Volver al gesto clave del fútbol.

Cómo se hace:

1. Primero cambia solo 45 grados.
2. Luego 90 grados cuando no duela.
3. El 180 viene al final porque es más agresivo.
4. Baja centro de gravedad y empuja el suelo.

Bien hecho se siente: control y confianza

Error típico: girar con pierna rígida o con miedo

Sube de nivel cuando: puedes hacerlo rápido sin protegerte



Dribbling progresivo

Para qué sirve: Llevar balón sin caos al principio.

Cómo se hace:

1. Empieza con conos separados y líneas amplias.
2. Usa cambios suaves de ritmo.
3. Acerca conos y aumenta velocidad solo si no duele.
4. Añade reacción/oposición al final.

Bien hecho se siente: balón controlado, cuerpo relajado

Error típico: hacer regates de partido antes de tiempo

Sube de nivel cuando: dribbling rápido sin dolor ni reacción



Golpeo progresivo

Para qué sirve: Recuperar pase largo y chut sin irritar la inserción.

Cómo se hace:

1. Semana inicial: pases suaves.
2. Luego golpeo al 40-50%.
3. Después 60-70%, luego 80-90%.
4. El chut máximo llega solo al final.

Bien hecho se siente: golpe limpio sin pinchazo

Error típico: probar disparos fuertes para ver si ya está

Sube de nivel cuando: puedes chutar fuerte y al día siguiente estás igual

7. Tests semanales

Haz estos tests cada domingo. No busques marca mundial. Buscas saber si puedes subir carga o si tienes que repetir fase.

Nº	Test	Medida	Cómo interpretarlo
1	Tos/estornudo	0-10	¿Duele la zona baja abdominal/ingle cuando sube la presión?
2	Squeeze/adducción	0-10	Aprieta balón 5 segundos. Dolor máximo permitido para avanzar: 0-2.
3	Copenhagen	reps	Cuenta repeticiones limpias por lado.
4	Carrera	%	Máxima intensidad tolerada sin dolor: 60, 70, 80, 90, 95, 100%.
5	Cambio de dirección	sí/no	45, 90 y 180 grados sin protegerte.
6	Día siguiente	mejor/igual/peor	Este es el test más importante.

Hoja de seguimiento

Semana	Dolor tos	Squeeze	Copenhagen	Sprint %	COD	Día sig.	Decisión
1							subir / repetir / bajar
2							subir / repetir / bajar
3							subir / repetir / bajar
4							subir / repetir / bajar
5							subir / repetir / bajar
6							subir / repetir / bajar
7							subir / repetir / bajar
8							subir / repetir / bajar
9							subir / repetir / bajar
10							subir / repetir / bajar

8. Recuperación invisible: sueño, comida y carga

La zona inguino-pública no se recupera solo con ejercicios. También necesita energía, sueño y semanas sin picos absurdos de carga.

Área	Regla simple
Sueño	Apunta a 8 horas. Si duermes poco, toleras peor la carga y te recuperas peor.
Proteína	Objetivo práctico: 1,6-2,0 g/kg/día si entrenas fuerte. Reparte en 3-5 comidas.
Hidratos	No hagas pretemporada sin gasolina. Los días de campo, velocidad y fuerza necesitan carbohidratos.
Creatina	3-5 g/día puede ser útil para fuerza/potencia si no tienes contraindicación y te sienta bien.
Alcohol	Mala idea durante readaptación. Peor sueño, peor recuperación y peor control de carga.
Peso corporal	No hagas déficit agresivo ahora. Quieres reparar tejido y ganar potencia, no llegar vacío.

Carga semanal

No subas todo a la vez. Si subes sprint, no subas también cambios de dirección, chut y gimnasio pesado en la misma semana. El cuerpo tolera una novedad grande, no cinco.

9. Checklist antes de competir

	No hay dolor claro con tos/estornudo.
	Palpación de aductor/pubis sin dolor importante.
	Aducción isométrica fuerte sin dolor >2/10.
	Copenhagen largo 3 x 6 por lado sin reacción.
	Sprint lineal 95-100% sin dolor.
	Frenada fuerte sin dolor ni miedo.
	Cambio de dirección 45, 90, 135 y 180 grados sin protegerte.
	Dribbling rápido y cambios de ritmo sin dolor.
	Golpeo/chut al 90-100% sin reacción 24-48 h.
	Tres sesiones de campo en una semana sin empeorar.
	Primeros minutos de partido superados sin reacción al día siguiente.

Decisión

Si faltan 1-2 puntos, puedes entrenar con restricciones. Si faltan puntos de sprint, frenada, cambio de dirección o golpeo, no estás listo para partido completo.

10. Qué llevar al médico/fisio/readaptador

Este apartado sirve para que la valoración sea más concreta y no se pierda tiempo.

Preguntas útiles

- ¿El dolor encaja más con adductor-related, inguinal-related, pubic-related o combinación?
- ¿Hace falta ecografía dinámica para descartar hernia oculta o debilidad de pared posterior?
- ¿Hace falta RM de pelvis/pubis con cortes adecuados para recto abdominal, aductores y sínfisis púbica?
- ¿Hay signos de lesión aponeurótica recto-aductor u osteítis púbica?
- ¿Qué criterios objetivos usarás para autorizar sprint, COD, golpeo y partido?

Datos que conviene apuntar

- Dónde duele exactamente: abdominal bajo, canal inguinal, pubis, aductor, testículo/periné, cadera.
- Qué lo reproduce: tos, estornudo, abdominales, sprint, chut, giro, estar sentado, subir escaleras.
- Si hay bulto o sensación de masa.
- Dolor 0-10 antes, durante y al día siguiente de entrenar.
- Qué ejercicios toleras y cuáles no.

Fecha de control sugerida

Si tras 14 días de fase 1-2 no hay mejora clara, o si el dolor con tos/adducción sigue alto, no sigas apretando a ciegas: pide valoración deportiva y considera imagen según exploración.

11. Fuentes y base del documento

Este informe combina el informe previo del caso, consensos de dolor inguinal en deportistas, evidencia sobre ejercicio activo, protocolos de aductores, prevención con Copenhagen y guías generales de nutrición/suplementación deportiva. Las referencias están incluidas para que el profesional que lo revise pueda contrastar el enfoque.

- [1] Informe previo aportado por el usuario: dolor abdominal al toser/estornudar con molestias en aductores; hipótesis de síndrome inguino-púbico deportivo y descarte de hernia.
- [2] Weir A. et al. Doha agreement meeting on terminology and definitions in groin pain in athletes. British Journal of Sports Medicine, 2015. <https://bjsm.bmj.com/content/49/12/768>
- [3] Serner A. et al. Return to Sport After Criteria-Based Rehabilitation of Acute Adductor Injuries in Male Athletes. Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2020. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2325967119897247>
- [4] Harøy J. et al. The Adductor Strengthening Programme prevents groin problems among male football players: a cluster-randomised controlled trial. British Journal of Sports Medicine, 2019. <https://bjsm.bmj.com/content/53/3/150>
- [5] Pulici L. et al. Return to sport after conservative versus surgical treatment for pubalgia in athletes: a systematic review. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 2022. <https://link.springer.com/article/10.1186/s13018-022-03376-y>
- [6] Lahuerta-Martín S. et al. The effectiveness of non-surgical interventions in athletes with groin pain: a systematic review and meta-analysis. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 2023. <https://link.springer.com/article/10.1186/s13102-023-00684-6>
- [7] Thomas D.T. et al. Nutrition and Athletic Performance. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and ACSM. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2016. [https://www.jandonline.org/article/S2212-2672\(15\)01802-X/fulltext](https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(15)01802-X/fulltext)
- [8] Maughan R.J. et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. British Journal of Sports Medicine, 2018. <https://bjsm.bmj.com/content/52/7/439>

Última nota

La ambición deportiva es correcta, pero la zona inguino-púbica premia la progresión. Si respetas los criterios, puedes entrenar fuerte. Si saltas fases, aumenta el riesgo de volver al punto inicial.